

31 - Les Anxiolytiques - Pr. BENALI

(0:07 - 0:51)

Chers étudiants, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième cours qui s'intitule les anxiolytiques. Un certain nombre d'objectifs pédagogiques ont été fixés, et au terme, comme d'habitude de ce cours, un étudiant en cinquième année sera en mesure de définir un anxiolytique, de connaître le mécanisme d'action et de classer les différents anxiolytiques, de cerner leurs indications, leurs contre-indications et leurs effets secondaires, et bien évidemment, maîtriser leur modalité de prescription.

(1:03 - 1:36)

Comme d'habitude, mon plan reste inchangé. Je vais introduire la question tout en définissant les anxiolytiques et dire trois ou quatre mots sur les enjeux de la question, donner les différentes classes des anxiolytiques, parler des mécanismes d'action et dire leurs indications, leurs contre-indications et les effets secondaires, pour finir par les modalités de prescription. Je porte à votre connaissance que l'évaluation de ce cours se fera sous le mode de questions à choix multiple.

(1:40 - 2:07)

Un anxiolytique peut être une substance ayant une activité sédatrice sur l'anxiété et sur la tension émotionnelle. Un médicament anxiolytique, quant à lui, soulage les symptômes d'anxiété aiguë, subaiguë au chronique, et on parle des faits d'anxiolyse. En général, il est associé à une prise en charge psychothérapeutique.

(2:12 - 2:56)

Il s'agit d'une question de l'importance capitale, tout simplement parce que les anxiolytiques ont démontré une efficacité sur les signes anxieux en prescription ponctuelle. Retenez que la prescription doit être ponctuelle, tout simplement parce que c'est une classe thérapeutique qui est à la fois surprescrite et malheureusement surconsommée par les patients et cela va donner à la longue ce qu'on appelle une dépendance. Donc il est indispensable à ce que le praticien améliore le bon usage des anxiolytiques.

(3:01 - 3:44)

Les médicaments anxiolytiques sont classés selon leur structure chimique et on distingue principalement deux grandes classes, les benzodiazépines, qui dominent la classe par leur nombre, et les carbamates. Et puis vient l'hydroxyzine, la buspirone et d'autres médicaments. Sur ce tableau, il y a la spécialité, il y a la DCI du médicament et surtout la demi-vie, parce que c'est très important, vous allez voir comment la demi-vie conditionne le choix d'une prescription.

(3:45 - 4:25)

Regarde la demi-vie, il y a la dose et la posologie par rapport aux médicaments et par quelle voie d'administration est donnée la benzodiazépine. Il faut savoir que ce qui est en rouge comme l'altrazolam, le xanax, le lorazepam, le temesta, le bromazepam comme le lexomide, le chlorazepam dit potassique, le tranxène, le nordazepam comme le nordaz, ce sont les médicaments les plus utilisés au Maroc. Les autres n'existent pas au Maroc, comme par exemple l'oxazepam, le serresta, qui est un anxiolytique très utilisé en matière d'addictologie et que malheureusement n'existe pas sur le marché marocain.

(4:26 - 5:04)

Et je ne manquerai pas de vous dire que tous vous connaissez le diazepam, le valium et le prazepam, le lisanxia. Donc ce qui est à retenir sur ce tableau, c'est surtout les demi-vies et surtout la dose journalière, on va le voir plus tard. D'autres substances et d'autres médicaments non-benzodiazépiniques ont une activité d'anxiolyse comme la tharax, l'hydroxyzine, et comme l'etifoxyne, le strézum.

(5:04 - 5:36)

Là aussi il y a la demi-vie, la présentation et la posologie et la dose journalière. Pour le mécanisme d'action des anxiolytiques, il est intéressant de rappeler brièvement la physiopathologie de l'anxiété qui est tout à fait normale chez l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un signal d'alarme qui va préparer tout sujet à faire face à une menace extérieure identifiée.

(5:37 - 6:33)

Je vous dis à titre d'exemple, vous préparez un examen, c'est normal que vous ayez une anxiété, une appréhension et cette appréhension va mobiliser la personne pour qu'elle puisse se préparer à l'examen et bien évidemment faire face aux épreuves de l'examen, faire face au stress lié à l'examen. Mais l'anxiété risque de devenir pathologique à la fois par l'intensité de sa symptomatologie mais aussi par le retentissement qu'a cette anxiété sur la personne. Ce retentissement, il est à la fois lié aux manifestations somatiques comme les manifestations cardiovasculaires, respiratoires, digestives, neurovégétatives et neuromusculaires et par rapport aux manifestations psychiques, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient émotionnelles, avec une inquiétude, un sentiment de danger, de crainte et surtout de perdre le contrôle.

(6:33 - 7:49)

La personne craint de perdre le contrôle, ce qui va donner bien évidemment le corollaire sur le plan comportemental, que ce soit une inhibition, une fuite en avant ou une agitation psychomotrice. L'anxiété va à la fois se matérialiser dans son acuité, soit elle est aiguë, soit elle est permanente ou généralisée et vous avez vu sur le cours des troubles anxieux les différents types d'anxiétés qui existent, une anxiété dite dirigée ou une anxiété dite généralisée. Ces états

anxieux vont être générés et vont faire bien évidemment appel à deux choses principales, à la fois les structures cérébrales, et je vous ai cité le cortex, la mygdale, l'hypothalamus et les autres qui participent à la genèse des états anxieux avec la participation des neurotransmetteurs comme le GABA, la sérotonine et la noradrénaline mais vous le savez tous, il faut insister sur le système GABA qui est mis en jeu d'une manière très importante.

(7:57 - 8:57)

Les anxiolytiques vont alors réduire ou supprimer l'angoisse et provoquent dans un certain nombre de cas une sédation. Je vous signale qu'un anxiolytique n'a pas un effet antipsychotique ni une action antidépressive, donc ça ne sert absolument à rien de les prescrire pour séviser, pour réduire un état délirant ou pour traiter une dépression et on voit qu'il y a une surconsommation, une surprescription et malheureusement parfois, ces médicaments sont indiqués dans des cas comme la psychose ou la dépression, ce qui n'est pas une bonne chose. L'action au niveau des récepteurs GABA, je l'ai dit, c'est le site d'action des benzodiazépines par prédilection et si on prend l'hydroxycine, c'est l'histamine parce que c'est la taraxelle antihistaminique et pour la buspirone, elle agit au niveau de la sérotonine.

(8:59 - 9:47)

Tous les médicaments anxiolytiques ont des actions ou des mécanismes d'action qui restent plus ou moins non élucidés mais les benzodiazépines ont eu un essor considérable en matière de connaissance par rapport aux mécanismes d'action et il est bien évidemment le mieux connu et c'est la raison par laquelle on le prend comme un type de description des mécanismes d'action des anxiolytiques. J'avais signalé au départ qu'il faut insister sur le système GABA-ergique tout simplement parce que le système GABA est un système tranquilisant naturel. Chaque être humain a, possède, un système qui s'appelle le système GABA-ergique et ce système permet une tranquillisation de l'esprit, de l'émotion et tout.

(9:48 - 10:36)

Que vient faire une benzodiazépine ? Elle vient se fixer sur le récepteur du complexe accepteur du GABA, qui s'appelle le GABA-A. Cette modification du récepteur va rendre le médicament plus sensible au GABA ce qui augmente une entrée du chlore déclenché par le GABA et par conséquent l'effet tranquilisant naturel va être amplifié. Et comme vous le voyez en bas, un usage prolongé va rendre les récepteurs GABA-A moins sensibles et au moins nombreux, ce qui va donner une tolérance et cette tolérance va appeler la personne à augmenter les doses pour avoir le même effet précédent.

(10:37 - 11:22)

Et à l'arrêt de ce médicament, du benzodiazépine, on aura un syndrome de sevrage qui est un syndrome très contraignant et malheureusement parfois très dangereux. Les anxiolytiques qui

sont donnés à viser d'anxiolyse, ça veut dire apaiser l'angoisse d'une personne, risquent d'avoir un effet sédatif, un effet mieux relaxant, un effet hypnotique. Ces trois effets, vous pouvez l'imaginer, risquent d'être très dévastateurs par rapport à la manipulation de machines ou à la conduite de véhicules.

(11:22 - 11:51)

À la langue, ces médicaments risquent d'avoir un effet amnésien. Quelqu'un qui va prendre une benzodiazépine risque d'oublier un rendez-vous, risque d'oublier une prise de médicament et ils ont un effet qui est un effet anticonvulsivant, c'est-à-dire on peut les donner en cas de crise convulsive. Les benzodiazépines ont une absorption totale par voie orale.

(11:52 - 12:16)

Leur pharmacocinétique stipule que leur distribution est large au niveau périphérique et cérébral. Elles ont une liaison protéique élevée et un métabolisme hépatique et une élimination rénale. Et on distingue trois types de benzodiazépines par rapport à leur demi-vie.

(12:17 - 13:10)

Il y a celles qui ont une demi-vie brève, c'est-à-dire inférieure à 12 heures, intermédiaire entre 12 heures et 24 heures et au-delà de 24 heures, la demi-vie est estimée comme étant longue. Quant au carbamate, la demi-vie est variable, elle est entre 6 heures et 16 heures, un catabolisme hépatique très important et une liaison protéique élevée comme celle des benzodiazépines, une faible élimination au niveau du lait maternel et une élimination rénale. Quand est-ce qu'on va prescrire un médicament anxiolytique ? Devant tout état anxieux, il ne faut pas prescrire systématiquement et automatiquement un anxiolytique.

(13:12 - 13:51)

Tout simplement parce que cela appelle à une analyse clinique très rigoureuse afin de ne pas entraîner une surconsommation, une surprescription. Mais il faut cibler ce qu'on appelle le retentissement important des manifestations anxieuses sur le fonctionnement quotidien et la qualité de vie. C'est-à-dire l'anxiété peut-être passagère, peut-être ponctuelle, mais elle devient pathologique quand il y a un retentissement important et ce retentissement se fera sur le fonctionnement d'une personne.

(13:52 - 14:29)

Quand est-ce qu'on peut aussi prescrire une benzodiazépine ou un traitement anxiolytique ? C'est que l'on a fait appel à une psychothérapie ou à des approches non médicamenteuses et cela se sonde par un échec. À partir de là, je pense qu'il faut se pencher sur une prescription d'anxiolytique. Donc je dis que l'anxiété pathologique est une indication privilégiée d'un traitement anxiolytique.

(14:29 - 14:54)

Surtout quand on parle d'attaque de panique ou ce qu'on appelait auparavant crise d'angoisse aiguë. C'est prescrit aussi quand il y a des états d'agitation et quand il y a une agressivité. Les troubles anxieux que vous avez vu en pathologie ont prescrit un anxiolytique mais comme un traitement adjuvant à une psychothérapie et un traitement antidépresseur surtout.

(14:56 - 15:43)

Chez un patient schizophrène, l'angoisse accompagnant les signes psychotiques pourrait être aussi une indication à un traitement anxiolytique. La dépression, quand on prescrit un antidépresseur, en attendant le délai d'action des médicaments antidépresseurs, on peut donner un traitement anxiolytique à la fois pour prévenir la levée d'inhibition mais pour pouvoir apaiser le patient en attendant l'effet des antidépresseurs. Les indications des médicaments anxiolytiques sont très larges.

(15:44 - 16:29)

On peut les donner quand il y a des troubles du sommeil, quand il y a des terroirs nocturnes, quand il y a une instabilité motrice chez les enfants anxieux. Il faut surtout vous rappeler que c'est largement utilisé pour le sevrage d'alcool, dans le délirium trémens, en petite chirurgie ou en examen pour diagnostic, on peut les utiliser à visée sédatrice mais d'une manière ponctuelle, quand il y a des spasmes musculaires, quand il y a des convulsions du nourrisson et de l'enfant ou devant un état de mal épileptique. Il est indispensable de connaître pour chaque médicament ou pour chaque classe thérapeutique dans quel cas il ne faut pas les utiliser.

(16:29 - 17:10)

Donc il s'agit là d'une analyse très soignée de l'état somatique du patient afin de savoir si on peut les donner ou pas. Et c'est ainsi que, par exemple, les benzodiazépines sont interdites devant une insuffisance respiratoire sévère, quand il y a une insuffisance hépatique sévère, devant un syndrome d'apnée de sommeil. La myasthénie, qui était une contre-indication absolue, est devenue relative depuis quelques années et il faut bien évidemment des précautions d'emploi chez le sujet âgé qui a un risque de chute à un syndrome confusionnel en association avec l'alcool.

(17:10 - 18:24)

Donc je vous invite aussi à mieux connaître notamment les contre-indications des benzos et des carbamates, bien évidemment celle de l'hydroxyzine aussi parce que la paraxe est largement utilisée au Maroc. Pour chaque prescription d'un médicament, il faut insister, comme c'était le cas pour les antidépresseurs et pour les timorégulateurs, c'est que l'efficacité d'un traitement est

aussi assujettie à une bonne tolérance du traitement, ça veut dire l'absence ou l'existence à un degré moindre d'effets indésirables. Donc ces effets sont liés en grande partie aux mécanismes d'action, ils sont, j'allais dire, inévitables pour les benzodiazépines qui vont entraîner forcément une sédation, une addition de l'effet de l'alcool si le patient associe une benzo avec sa consommation d'alcool, parfois des réactions paradoxales surtout chez un enfant et le sujet âgé avec une excitation ou une aggravation de l'agitation onctueuse.

(18:24 - 19:24)

Un phénomène de tolérance qui est à la base d'une dépendance à la fois physique et psychique et par conséquent à l'arrêt du médicament, un syndrome de sevrage qui va se manifester par une symptomatologie physique mais aussi psychique avec une anxiété, des tremblements, des sueurs et des nausées. Des troubles de mémoire et d'attention à la fois à court terme mais surtout à long terme et des surdosages de toxicité avec parfois une ataxie, un coma avec des pressions respiratoires sévères et décès. Un des effets indésirables sur lequel j'insiste, c'est celui qui est lié à un mésusage des traitements anxiolytiques notamment benzodiazépiniques.

(19:24 - 20:54)

Et ce mésusage est à la fois lié soit à une prescription inadéquate ou malheureusement à un patient qui va se procurer ces médicaments pour pouvoir les prendre et chez qui va s'installer une tolérance, c'est-à-dire une diminution de la réponse à une substance après administration répétée et qui est suivie d'une dépendance et la dépendance va être matérialisée par un état psychologique et ou physiologique, c'est-à-dire une dépendance physique et une dépendance psychologique qui nécessite la répétition de l'administration de cette substance afin d'éviter l'apparition de symptômes d'abstinence, ce qu'on appelle le sevrage. Donc il s'agit là d'un effet indésirable très connu des benzodiazépines qui va entraîner une dépendance ou ce qu'on appelle une addiction à cette substance et qui risque de se transférer sur d'autres substances, notamment l'alcool et le cannabis. Il est aussi indispensable de connaître certains effets indésirables des autres molécules et on a une somnolence, des troubles respiratoires, une baisse de la tension artérielle, des vertiges par les carbamates.

(20:55 - 21:40)

L'hydroxyzine va entraîner des nausées, constipation, des vomissements, des troubles de l'accommodation, une sécheresse de la bouche, un syndrome de rétention des urines, une somnolence, des convulsions, des mouvements anormaux, des tremblements, des vertiges et de l'insomnie. Quant à la buspirone, elle peut donner des sensations vertigineuses et ou hébrieuses essentiellement en début de traitement. J'arrive au chapitre sur les modalités de prescription des anxiolytiques dont le but essentiel est de réduire l'anxiété sans induire une sédation.

(21:43 - 22:13)

Donc il faut rechercher et prendre en charge une origine des manifestations anxieuses. Il peut s'agir d'une dépression, d'un autre trouble psychiatrique ou d'une pathologie organique comme l'hypertiruidie, l'hyperparatiruidie, le phœochromocytome ou l'hypoglycémie, il y en a d'autres aussi, et un effet d'anxiété qui est lié à une crise de toxiques comme la caféine, de l'alcool ou d'autres substances psychoactives. Donc il faut évaluer la situation somatique du patient.

(22:19 - 23:08)

Au regard de cette analyse somatique, il y a une conduite à tenir, à adopter. Si par exemple on a une insuffisance rénale ou hépatique, on va diminuer les posologies des benzodiazépines, on privilégiera ceux qui ne sont pas métabolisés par le foie comme l'oxazepam, le Seresta ou le lorazepam, le Temesta. Le sujet âgé a une grande sensibilité à ses médicaments et donc il faut privilégier la plus faible dose active qui est généralement équivalente à la moitié de dose adulte et donner des molécules sans effet sédatif privilégiées des benzodiazépines à demi-vie courte ou intermédiaire qui ne sont pas ou peu métabolisées.

(23:15 - 23:41)

En ambulatoire, on les prescrit après échec d'autres mesures non médicamenteuses. Il va falloir tester la sensibilité du patient à d'éventuels effets sédatifs, privilégier la voie orale avec des faibles doses et progressivement croissantes en deux ou trois prises. Il ne faut pas associer deux ou plusieurs benzodiazépines et surtout insister sur une durée maximale de 12 semaines.

(23:42 - 24:11)

L'arrêt doit être progressif sur 4 à 10 semaines et si on est amené à represcrire ce médicament au-delà de 12 semaines, il va falloir faire une réévaluation clinique très rigoureuse. Je vous donne à titre d'exemple un cas d'attaque de panique avec agitation. On donne un traitement à base de Trancsène à 50 mg ou donner une ampoule de Valium à 10 mg.

(24:12 - 24:52)

Quand on a une anxiété permanente, on peut avoir une prise unique d'une benzodiazépine à demi-vie longue ou posologie étagée comme l'exemple du Lexomil qui est quadricécable, dont un quart de comprimé, trois fois par jour. La durée est limitée du traitement à 4 à 6 semaines avec diminution progressive. L'insomnie n'est pas une indication privilégiée des benzodiazépines, mais si on est amené à prescrire une benzo, il vaut mieux prescrire un médicament à demi-vie courte ou un hypnotique non benzodiazépine avec une durée de traitement de 8 à 15 jours.

(24:58 - 25:53)

Ce tableau résume un certain nombre d'oxylithiques, leur demi-vie, leur forme galénique et bien évidemment la dose moyenne à prescrire. Si je donne à titre d'exemple ceux qui sont prescrits au

Maroc comme le Lexomil qui est un comprimé à 6 mg, on donne 6 à 18 mg par jour, ou le Xanax qui est un comprimé dosé à 0,5 mg, on peut donner de 0,5 à 1 mg et on peut aller jusqu'à 2 mg. Je pense qu'il s'agit de doses à retenir, surtout par rapport aux médicaments qui existent au Maroc, donc on exclut le Serresta, mais il est aussi indispensable ou important de connaître ce médicament parce qu'il y a des patients qui le ramènent de l'étranger, donc il vaut mieux connaître les posologies, les doses et la demi-vie.

(25:56 - 26:40)

Un certain nombre de points sont essentiels à dire aux patients parce qu'il faut être clair par rapport surtout à la conduite d'automobile. Dans certains pays, sur l'ordonnance, il est mentionné qu'il est interdit de conduire sous l'effet de benzodiazépines ou de manipuler des machines, notamment des machines tranchantes, et insister par rapport à la consommation d'alcool. Il ne faut pas hésiter à demander aux patients ou à la patiente s'ils consomment une substance psychoactive dont l'effet risque d'être majoré en l'associant avec la benzodiazépine.

(26:41 - 27:24)

C'est pour cela que la psychoéducation et l'information du patient sont indispensables par rapport à la durée du traitement, par rapport aux effets secondaires du traitement, et un certain nombre de règles hygiéno-diététiques à respecter. L'évaluation doit être régulière parce qu'il faut avoir une idée très claire sur l'efficacité et surtout sur la tolérance, c'est-à-dire les effets secondaires du médicament. Quand on a un trouble anxieux chronique, on a plus l'indication d'une psychothérapie ou d'un traitement antidépresseur avec d'autres méthodes et d'autres mesures comme la relaxation, la sophrologie et d'autres.

(27:25 - 28:11)

Donc il ne faut pas, dans les troubles anxieux chroniques, les benzodiazépines ont des limites d'indication dans ce registre. Quand le patient est hospitalisé, on peut aussi recourir à la voie veineuse, notamment quand il y a des syndromes confusionnels, quand il y a des attaques de panique très contraignantes et on peut utiliser aussi la forme intramusculaire ou la voie orale. Il est important de disposer d'un matériel de réanimation surtout quand on donne un médicament par voie intraveineuse parce qu'en cas d'injection intraveineuse rapide, on a un risque d'apnée.

(28:11 - 28:48)

Et toujours, il faut arrêter le traitement d'une manière progressive, surtout si le patient le prend en hospitalisation et quittera l'hôpital après. Il faut bien évidemment mentionner le protocole dégressif de ce médicament afin d'éviter un syndrome de sevrage. Il est aussi important de surveiller la bonne prise du traitement, voir comment les symptômes anxieux évoluent, faire attention ou prêter attention à l'appétit et au sommeil du patient.

(28:49 - 29:23)

Cela va amener à ajuster les posologies, notamment quand il y a des somnolences ou anesthésie au début du traitement et guetter la survenue d'une dépendance. Avant de conclure, quel est l'essentiel des médicaments anxiolytiques ? Il faut savoir que les benzodiazépines sont les anxiolytiques les plus couramment prescrits. Ce sont des molécules qui sont efficaces sur une courte période mais qui ne traitent pas les causes de l'anxiété.

(29:24 - 30:00)

Ce sont des médicaments qui sont responsables de nombreux effets indésirables, aux conséquences parfois graves. Ils sont utilisés ou doivent être utilisés à dose minimum et pour une durée minimale qui ne doit pas dépasser 12 semaines. Ce qui porte l'intérêt de cette question à l'information du patient, une information qui se veut être loyale, approximative, appropriée et simple, avec une réévaluation de la situation du patient et surtout des modalités d'arrêt.

(30:03 - 30:38)

En conclusion, c'est une prescription qui doit être mesurée et le plus possible de courte durée. Il faut être très attentif aux effets secondaires immédiats et différés et cela appelle, comme pour les autres questions, un intérêt de l'éducation du patient, de l'information du patient, du soutien et d'accompagnement du patient. Je vous souhaite alors une bonne écoute de ce cours sonorisé et je vous souhaite un bon courage.

(30:39 - 30:39)

Merci.